REIN · SURRÉNALE · RS-02

Incidentalome surrénalien

ESE/ENSAT 2023
scanner sans injection, wash-out, IRM, suivi

Définition : masse surrénalienne découverte sur une imagerie non réalisée pour une pathologie surrénalienne. Deux questions systématiques : **bénin ou malin ?** et **sécrétant ou non ?** (bilan hormonal pour tous : test de freinage à la dexaméthasone 1 mg ; métanéphrines si non clairement bénin à l'imagerie ; aldostérone/rénine si HTA ou hypokaliémie).

ALGORITHME D'IMAGERIE ESE/ENSAT 2023

Scanner sans injection en 1re intention

›

Homogène et ≤ 10 UH
Adénome riche en lipides : bénin, aucune imagerie supplémentaire quelle que soit la taille (≈ 70 % des cas)

›

Homogène, 11–20 UH, < 4 cm
Imagerie complémentaire immédiate (wash-out, IRM) ou scanner sans injection à 12 mois

›

> 20 UH ou hétérogène, ou ≥ 4 cm et hétérogène
Discussion en **RCP** ; chirurgie le plus souvent

Seuil de 10 UH : sensibilité 100 %, spécificité 58 % · seuil de 20 UH : sensibilité 97 %, spécificité 77 %. Le seuil de taille de 4 cm de 2016 n'est plus un critère isolé.

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

Scanner avec wash-out

- Sans injection, portal (60–70 s), tardif (15 min)
- **Wash-out absolu** = (portal − tardif) / (portal − sans injection) ; ≥ 60 % : adénome
- **Wash-out relatif** = (portal − tardif) / portal ; ≥ 40 % : adénome
- Moins fiable que la densité spontanée (phéochromocytomes et métastases peuvent laver)

IRM

- **Chute de signal en opposition de phase** (graisse intracellulaire) : adénome
- Utile si 10–30 UH, chez l'enfant, la femme enceinte
- Phéochromocytome : T2 souvent intense, mais non spécifique

TEP-TDM au FDG

- Masse indéterminée, contexte oncologique
- Fixation < foie : en faveur de la bénignité

BIOPSIE

Seulement si elle change la prise en charge (cancer extra-surrénalien connu) et **après exclusion d'un phéochromocytome**

LÉSIONS À RECONNAÎTRE

LÉSION	ARGUMENTS D'IMAGERIE
Myélolipome	Graisse macroscopique (< −30 UH) : bénin, aucun suivi
Kyste, hématome	Pas de rehaussement ; hématome : densité spontanée élevée, régression au contrôle
Phéochromocytome	> 10 UH, rehaussement intense, parfois kystique ou hémorragique ; métanéphrines indispensables
Corticosurrénalome	Grande taille, hétérogène, nécrose, calcifications, envahissement de la veine cave inférieure
Métastase	Contexte de cancer, bilatérale, croissance, hétérogène

SUIVI D'UNE MASSE INDÉTERMINÉE NON OPÉRÉE

Contrôle
scanner sans injection ou IRM à **6–12 mois**

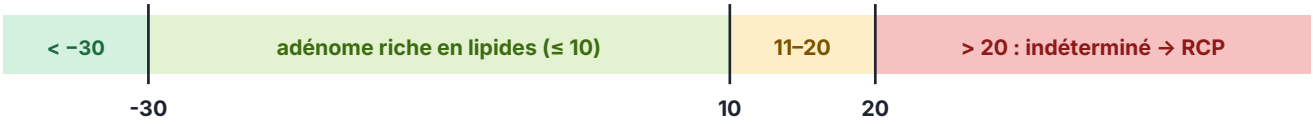
Croissance significative
> 20 % et ≥ 5 mm du plus grand diamètre : chirurgie proposée

Croissance infra-seuil
nouveau contrôle à 6–12 mois

Incidentalome surrénalien (suite)

ATLAS VISUEL

Densité au scanner sans injection (UH)



graisse : myélolipome

homogène < 4 cm : contrôle

IRM : chute de signal en opposition de phase = graisse intracellulaire (adénome)

Schémas simplifiés, non à l'échelle

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Adénome surrénalien
Radiopaedia · densité, wash-out
radiopaedia.org/articles/adrenal-adenoma

Déplacement chimique (cas)
Radiopaedia · opposition de phase
radiopaedia.org/cases/adrenal-adenoma-chemical-s

Wash-out surrénalien
Radiopaedia · calcul absolu et relatif
radiopaedia.org/articles/adrenal-washout

Myélolipome surrénalien
Radiopaedia · graisse macroscopique
radiopaedia.org/articles/adrenal-myelolipoma

Protocole scanner surrénales
Radiopaedia · phases
radiopaedia.org/articles/ct-adrenals-protocol

Sources : ESE 2023 adrenal incidentaloma guideline (ECE 2023) – www.ese-hormones.org/media/jjwm0ip2/adrenal-incidentaloma-gu... · Recent updates adrenal incidentalomas (PMC) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10475962/